Université Paris Cité

Enjeux sociaux et éthiques relatifs aux maladies chroniques

PASS – UE 7 SHS

Céline Lefève, co-responsable de l'UE SHS

Professeure des universités en philosophie de la médecine (Département Histoire et Philosophie des Sciences/UMR CNRS SPHERE/Institut Hors Murs La Personne en médecine)

celine.lefeve@u-paris.fr

APPRENDRE SAUF DIAPOSITIVES 14-15 et 18-19

Université Paris Cité

Nota bene : Ce cours est protégé par le droit d'auteur.

Cf. décision du Tribunal judiciaire de Lyon du 10 septembre 2024

https://justice.pappers.fr/decision/e1340b815f2b58554d4b14084abcfaa58cd9c455

Introduction

Définitions

- Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : affection de longue durée (de 6 mois ou plus).

- Selon le Haut Conseil de la Santé Publique français (2009) :

- **la présence d'un état pathologique de nature physique, psychologique ou cognitive, appelé à durer ;**
- **une ancienneté minimale de trois mois, ou supposée telle;**
- **un retentissement sur la vie quotidienne comportant au moins l'un des trois éléments suivants :**
  - **une limitation fonctionnelle des activités ou de la participation sociale,**
  - **une dépendance vis-à-vis d'un médicament, d'un régime, d'une technologie médicale, d'un appareillage ou d'une assistance personnelle,**
  - **la nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d'une aide psychologique, d'une adaptation, d'une surveillance ou d'une prévention particulière pouvant s'inscrire dans un parcours de soins médico-social.**

- **Epidémiologie :** concerne 20 millions de patients en France
- **Maladies que l'on peut soigner, mais pas guérir (la maladie peut donc affecter la personne à la fois tous les jours et pour toujours).** Ex. asthme, diabète, drépanocytose, hypertension artérielle, lupus, maladie d'Alzheimer, maladies psychiatriques, mucoviscidose, sclérose en plaques, sida, etc. NB : on considère de plus en plus le cancer comme une maladie chronique dans la mesure où il requiert des traitements longs, peut comporter des séquelles et des risques de récidive et nécessiter une surveillance médicale plusieurs années après le traitement.

Université Paris Cité

➢ Enjeux du cours

-Décrire les aspects psychiques et sociaux de la vie avec une maladie chronique somatique

-Montrer qu'une vie normale est possible avec la maladie chronique, mais que la normalisation est un enjeu complexe, qui peut être compris différemment selon les acteurs et être source de malentendus

- En tirer quelques implications concernant les besoins de soin et les finalités de la médecine concernant les maladies chroniques

➢ Plan

I. Les activités de la personne malade chronique

II. L'enjeu complexe de la normalisation

Conclusion : La médecine de la maladie chronique : une médecine de la personne et du soin

I. Les activités de la personne malade chronique

1. Le travail identitaire de la personne malade chronique : de la rupture biographique à la reconstruction de soi

- Lorsque la maladie chronique (MC) apparaît au cours de la vie (et non dès la naissance ou la petite enfance), elle produit une remise en question de l'identité personnelle et sociale : des **changements identitaires** qui affectent des sentiments, valeurs et représentations; habitudes, activités, relations ; conceptions de soi et de son corps, significations données à l'existence, récits de soi de la personne = « **rupture biographique** »

Michael Bury, « Chronic illness as biographical disruption", *Sociology of Health and Illness,* 4, 1982, p. 167-182.

- En particulier, la MC et les traitements transforment le **corps**. Ils peuvent causer le sentiment d'une intrusion dans l'intimité corporelle : le corps (douloureux, ou changeant) peut être perçu comme autre, étranger, extérieur, aliéné. L'expérience de la MC introduit un sentiment d'étrangeté à soi et de dépossession de soi, au point que le sujet peut ne plus se reconnaître et avoir le sentiment de ne plus être lui-même. (cf. Claire Marin, *Hors de moi,* 2008 ; *La Maladie, catastrophe intime*, 2014)

⇒ **La personne se trouve devant la nécessité et la tâche de « devenir autrement la même », de maintenir une continuité biographique (suturer passé/présent), de recomposer ou reconstruire son identité qui est remise en question, voire effondrée.**

⇒ **Enjeu du soin (dispensé par des professionnels de santé ou des proches) : accompagner ces changements et cette recomposition identitaire, en vue d'aider la personne à**

✓ Maintenir ou rétablir **sa continuité biographique.** Peut passer par le récit de soi, instrument de restauration du sujet dans sa capacité à dire, se dire et agir dont la maladie et ses souffrances ont pu le déposséder (Paul Ricoeur);

✓ ce que la MC ne soit **qu'une partie, et non le tout, de sa vie et de son identité personnelle et sociale.**

⇒ Risques (en médecine et dans les relations sociales) : réduire l'identité *du* malade à l'identité *de* malade ; oublier que **s'approprier ces remaniements identitaires ne dépend pas de la volonté de l'individu, mais de la qualité des relations de soin et d'accompagnement dont il peut bénéficier.**

Université Paris Cité

2. Le travail du malade : un travail psychique et social

- La MC engendre des **désorganisations** multiples et répétées, des **ruptures** dans la vie personnelle et sociale du malade, un **désordre**.
- Elle exige du malade un **travail constant** pour permettre une **continuité de la vie sociale, mettre en ordre sa vie sociale en y intégrant les événements et transformations induits par la MC et maintenir ses relations sociales**. Le malade est contraint d'effectuer un **constant travail de négociation** pour articuler sa vie avec maladie et les autres sphères de sa vie (familiale, sociale). Par ex. il peut être contraint de redessiner son style de vie (changement de domicile, de travail, etc.)

La MC est un « **construction sociale négociée** » dont le patient est l'acteur principal (Isabelle Baszanger).

« *Dans leur travail de gestion, les malades doivent aller au-delà d'un travail de soins médicalement défini. Il leur faut aussi gérer les conséquences de la maladie sur leur organisation de vie, leurs rapports avec les autres et, jusqu'à un certain point, leur rapport avec eux-mêmes.* »

« L'enjeu de cette construction négociée est, pour le malade, le maintien de ses insertions sociales et d'une vie sociale aussi normale que possible et, pour l'ensemble des acteurs sociaux, l'établissement d'une grille de lecture qui permette d'appréhender cette situation nouvelle et instable. »

I. Baszanger, « Les maladies chroniques et leur ordre négocié », *Revue française de sociologie*, XXVII, 1986, p. 3-27.

- Exemples du « **travail de contrôle de la maladie** » (Anselm Strauss) :
  - contrôle des **émotions** dans les interactions médicales et sociales ;
  - contrôle de **l'information** dans les sphères privée et publique de manière à faire reconnaître le statut de malade sans être pour autant stigmatisé (cf. travail de la personne malade autour du stigmate 4 techniques du contrôle de l'information : dissimulation ; imputation des signes à une autre origine ; maintien d'une distance pour éviter les confidences ; dévoilement volontaire Erving Goffman, *Stigmates. Les usages sociaux des handicaps* (1963), Paris, Minuit, 1975)

3. La vie avec la maladie chronique : une tâche pratique

- Le travail psychique et social du malade chronique inclut une **multitude de micro-activités quotidiennes** très diverses. La personne malade doit agir dans tous les domaines de sa vie, en particulier sur son corps (auto-soins, régulation du sommeil, de la fatigue, du stress, prévention des symptômes), pour s'ajuster à l'imprévisibilité de la MC.

- Vivre avec une MC consiste à réfléchir et à prendre une **multitude de décisions**, « **faire une quantité de petits choix pratiques** », beaucoup de choix portant sur des actes qui peuvent paraître modestes mais qui ont une influence réelle sur l'état de santé : prendre ou non les médicaments prescrits, consulter ou non si cela ne va pas, aller travailler ou non, collaborer ou non aux gestes de l'infirmière, parler ou non de sa maladie à ses collègues et amis, cacher ou non ses émotions, rechercher ou non des informations médicales sur le net, etc.

⇒ ***Vivre avec une MC, c'est être (extrêmement) actif - et non passif.*** Dans la MC, la vie n'est pas un fait, mais une « ***tâche pratique* ».** Cf. Annemarie Mol, *Ce que soigner veut dire*. *Repenser le libre choix du patient*, Ed. Mines, 2009

⇒ ***Cette activité du malade peut être regardée comme un soin de soi. La personne malade chronique cherche à diminuer l'impact de sa maladie sur sa vie quotidienne et à préserver sa santé. Mais aussi à vivre selon ses valeurs, ses préférences, ses idéaux, ses aspirations, ses goûts etc. Survivre mais aussi vivre pleinement.*** Cf. commentaire de texte : C. Lefève, « Annemarie Mol. S'abandonner activement », in C. Lefève, L. Benaroyo, F. Worms (dir.), *Les Classiques du soin,* Paris, PUF, 2015, p. 193-208.





Université Paris Cité

4. Premières implications pour le soin médical

- **Pour les professionnels de santé, prendre soin d'une personne vivant avec une MC demande de connaître et de s'appuyer sur cette activité globale de la personne malade, sur ses savoirs expérientiels et ses compétences** (concernant la maladie, son corps, les symptômes, les effets des traitements, la vie quotidienne avec la maladie, les parcours de soin), **sur le soin qu'elle prend d'elle-même, sur ses relations de soin médicales et non médicales** (famille, aidants, amis, associations de patients, groupes de pairs ou de patients experts). **Il faut prendre en compte ses ressources ET ses difficultés.**
- **Le soin médical est un « bricolage partagé »,** effectué **ensemble** par les soignants et les soignés (ce n'est pas seulement la tâche des professionnels de santé). C'est une **pratique technique collaborative, à la fois entre soignants (médecins, infirmières, kinés, psys, diététiciens, etc.) et entre soignants et soignés.**

« *Le bon soin naît (…) d'un ensemble de personnes qui lui donnent une forme à inventer et à adapter continuellement dans la pratique de tous les jours*. » (Mol, p. 23)

- **Le soin dans la MC consiste dans un processus décisionnel continu.** Il consiste dans de **constants ajustements sur les buts à poursuivre et les moyens à utiliser afin de s'adapter continuellement à l'imprévisible de la maladie et des traitements.**

Conclusion de cette partie : Le soin médical dans la MC ne vise pas la guérison de la maladie, mais l'accompagnement et le soutien du malade dans sa vie avec la maladie.

II. L'enjeu complexe de la normalisation

Un enjeu important pour les personnes vivant avec une MC est de vivre la vie la plus normale possible : d'une part la plus semblable à celle qu'ils avaient avant la maladie, d'autre part la plus semblable à celle des bien portants…

« *L'activité principale des malades chroniques n'est pas seulement de rester en vie ou de contrôler leurs symptômes,* ***mais de vivre aussi normalement que possible, en dépit des symptômes et de la maladie****. Le caractère intrusif et variable des symptômes et des traitements (…) sont des facteurs qui jouent* ***sur le difficile équilibre entre la dé-normalisation et la normalisation de la vie.*** *La normalité n'est pas un état mais une* ***estimation*** *qui se négocie au travers des interactions sociales et des différentes situations auxquelles les personnes sont confrontées.* »

STRAUSS A. , CORBIN J. FAGERHAUGH S. GLASER B. G. MAINES D SUCZCEK B. WIENER C. *Chronic illness and the quality of life,* Saint-Louis, C. V. Mosby, 1975.

1. Les multiples significations de la normalisation

La normalisation correspond à la fois à

- **un processus d'appropriation de sa maladie par la personne malade**

- **l'attente par les médecins que la personne malade gère sa maladie et ses traitements le plus possible de manière autonome**

- **un idéal, une attente sociale (des proches, du monde du travail, etc.) qui peut être lourde à porter pour la personne malade.**

Université Paris Cité

2. Que signifie vivre une vie normale avec une maladie chronique ? Une réflexion issue de la philosophie de Georges Canguilhem (*Le normal et le pathologique,* Paris, PUF, 1966)

- **La vie avec la MC : une autre norme de vie.** La MC consiste à vivre une toute autre vie, une vie d'une toute autre allure, d'une toute autre qualité (sur les plans biologique, psychologique et social) en écart, voire en rupture, d'une part, avec sa vie antérieure, et, d'autre part, avec la vie des bien-portants.
- La norme de vie dans la MC est marquée par la **réduction des capacités du sujet à la fois d'adaptation et de participation à son monde** (ce que Canguilhem appelle la réduction de sa « normativité », cf. cours sur les définitions de la santé et de la maladie).
- Cette norme de vie est **précaire** : elle se maintient dans la durée **si** les conditions de vie (sur les plans biologique, psychologique et social) demeurent **stables** (par ex., des traitements, un régime alimentaire, de l'exercice physique régulier, etc. régulent les symptômes de la maladie et en freinent l'évolution), l'état global du malade **risquant** de se dégrader si ces conditions viennent à changer.
- **Mais** cette vie « normalisée » dans ces conditions, restreinte et contrainte, recèle **une part de normativité** : la personne, par les activités que nous avons décrites, définit, invente sa manière de « vivre avec » la maladie chronique. **Elle peut éprouver, considérer comme normale cette vie, l'apprécier, s'y sentir et s'y dire en bonne santé parce qu'elle parvient, malgré la MC, à s'y accomplir, s'y épanouir, y déployer ses valeurs, préférences, aspirations, etc.**

Université Paris Cité

=> Dans toute vie, y compris avec la maladie chronique, il y a de la normativité, de l'invention de normes : biologiques, psychologiques, sociales, culturelles, intellectuelles, esthétiques, etc.
=> **La MC amène la personne malade, son entourage et les professionnels de santé qui en prennent soin et l'accompagnent à faire d'une norme de vie ou d'une manière de vivre certes restreinte et contrainte, une norme de vie ou une manière de vie qu'elle valorise, qu'elle considère comme vivable et même épanouissante, car la personne parvient à y déployer ses propres valeurs, préférences, etc. , car elle demeure le sujet, car elle est à son initiative.**



Le peintre Matisse: exemple d'un sujet vivant une norme de vie restreinte et contrainte par la vieillesse et les maladies qui l'accompagnent, mais demeurant un sujet inventeur de normes esthétiques et menant une vie qu'il juge accomplie.





Le peintre Henri Matisse à Nice en 1950

Université Paris Cité

Une définition plus philosophique

- Condition dont on ne meurt pas si des traitements et soins peuvent la réguler et en modifier l'évolution, mais qui demeure **incurable**
- Caractérisée par une **oscillation** entre des phases de stabilité et de crises, par **l'imprévisibilité et l'incertitude**
- par **l'ambivalence**, **l'ambiguité d'être malade et de se sentir en bonne santé** : cf. Havi Carel, *La maladie. Le cri de la chair*, Paris, Vrin, 2022 (philosophe atteinte d'une lymphangioléiomyomatose, maladie rare qui touche les poumons et évolue souvent vers une insuffisance respiratoire)

p. 25 : « *J'ai appris à vivre la vie avec une tête de Janus : jeune mais vieille, avec une bonne mine mais malade, heureuse mais aussi incroyablement triste*. »

p. 89 : « *Tout comme des épisodes de maladie peuvent avoir lieu dans la santé, une expérience de santé dans la maladie peut avoir lieu, même s'il est souvent omis.* »

Cf. aussi Camus, A. et Gaille, M. (2025). En quête de matière étrangère : la philosophie de terrain à l'épreuve des maladies chroniques. *Critique*, 935(4), 36-47.



Université Paris Cité

*« Beaucoup de compte rendus suggèrent que **les malades chroniques peuvent se sentir en bonne santé sur les plans subjectifs et individuels. Ces perspectives reconnaissent la possibilité de la santé au sein de la maladie** (…). Un phénomène notable présent dans de nombreuses études est **le manque de corrélation entre la santé objective (le corps biologique) et le bien-être subjectif (l'expérience vécue)**.*

Etonnamment de nombreux malades évaluent leur santé comme bonne. Dans une étude de Stuifbergen, 73 % des personnes sondées qui vivaient avec une malade invalidante, ont évalué leur santé comme étant bonne ou excellente.

*De plus les définitions individuelles de la santé **varient** considérablement parmi les personnes sondées. Alors que certaines ont défini la santé comme « ne jamais être malade ou prendre des médicaments », d'autres ont **évoqué « être capable de prendre soin de moi », ou « profiter de la vie chaque jour », révélant la caractère multidimensionnel du concept de santé**. A la lumière de ces résultats, il devient nécessaire de changer la manière dont nous pensons la santé et la maladie. Nous devons modifier notre manière de voir celles-ci comme opposées et mutuellement exclusives pour parler d'un continuum ou d'un mélange des deux (…). **Il faut s'éloigner d'une mesure de la santé objective centrée sur le déficit et accorder un poids plus important aux comptes rendus subjectifs à la première personne ou aux expériences vécues. (…)***

***Ce changement est aussi exprimé dans le déplacement « du traitement vers le soin » (« from cure to care »)**. (…) Puisque l'attention est portée sur la pathologie et qu'une approche négative, centrée sur les déficits, est appliquée, l'expérience positive de la santé dans la maladie reste ignorée par la pratique médicale. »*

Havi Carel, *La maladie. Le cri de la chair*, Paris, Vrin, 2022, pp. 89-91

3. Les idéaux difficiles de la normalité et de l'autonomie

Une vie normale avec la maladie chronique implique pour la personne malade d'assumer de manière relativement autonome la gestion de sa maladie et de ses traitements.

Or, il peut être difficile pour le malade de se conformer à cette attente médicale et sociale d'être autonome.

En particulier, les prescriptions de la médecine peuvent conduire à **disqualifier, à juger négativement** les comportements individuels des malades, à les responsabiliser, voire à les culpabiliser, et à **sous-estimer les déterminants psycho-sociaux de leur vie avec la maladie chronique**.

- Par **exemple**, **les difficultés dans l'observance thérapeutique (le fait de ne pas suivre les prescriptions médicales pour prendre ses médicaments ou suivre ses traitements)** demandent de comprendre **les raisons du patient** qui peuvent être liées à
  - son appropriation difficile de la maladie,
  - des relations changeantes ou compliquées avec la médecine et les soignants,
  - la visibilité sociale du traitement (pas facile de prendre ses médicaments devant les collègues ou camarades à la cantine)
  - ses conditions sociales et économiques d'existence, etc.

Université Paris Cité

A LIRE SANS APPRENDRE

4. L'empowerment

Vivre la vie la plus normale possible et être le plus autonome possible passe par *l'empowerment* de la personne malade chronique.

C'est le processus par lequel une personne (ou un groupe de personnes) renforce son pouvoir d'agir, et, plus particulièrement, sa capacité à identifier et satisfaire ses besoins, résoudre ses problèmes et mobiliser ses ressources, de manière à avoir le sentiment de contrôler sa propre vie (Gibson).

- Dans la MC : processus consistant à **apprendre à vivre avec la maladie et à développer la capacité à prendre soin de soi et de sa santé en vue de reprendre le pouvoir sur la maladie et sur son existence.**
- **Par exemple, l'éducation thérapeutique du patient, dispensée notamment par des infirmiers ou d'autres patients (pour apprendre à reconnaître et gérer ses symptômes, pratiquer ses auto-soins, etc),** contribue à *l'empowerment* des patients.
- **Mais** *L'empowerment* demande d'être attentif aux **déterminants sociaux et environnementaux** de la santé sur lesquels les patients ne peuvent pas avoir prise.
- ***Et*** *l'empowerment* a besoin d'être enseigné et d'être soutenu par **des relations de soin (avec des professionnels de santé, des proches, des patients pairs).**

Aujoulat, Isabelle ; D'Hoore, William ; Deccache, Alain. *Patient empowerment in theory and practice: polysemy or cacophony?*. In: *Patient education and counseling*, Vol. 66, no. 1, p. 13-20 (2007)

Conclusion : l'autonomie ne signifie pas l'indépendance ou la solitude, mais bien l'inscription dans des relations de soin, d'accompagnement et de soutien qui permettent d'être autonome. C'est ce que l'on appelle **l'autonomie relationnelle.**

Conclusion : La médecine de la maladie chronique : une médecine de la personne et du soin

1) La MC demande à la médecine de se définir non comme lutte contre la maladie, mais comme **prise en soin de la personne malade**. **La médecine ne vise pas à traiter pour guérir (*to cure*), mais pour prendre soin (*to care*), pour contribuer à ce que la personne ait une vie heureuse avec la maladie. Passage du paradigme du *cure* au paradigme du *care*.**

2) Le soin prodigué par la médecine et les professionnels de santé est seulement l'un des aspects du soin dont les personnes malades chroniques ont besoin : soin familial, amical, amoureux, soin apporté par des pairs, collègues, soin qui se matérialise par la protection sociale, etc.

3) La médecine de la MC se définit par **l'accompagnement** et **le soutien de la personne malade** :

« *« La médecine de la personne » doit permettre non seulement le suivi biomédical de plusieurs maladies, mais aussi, et peut-être surtout,* ***une prise en compte psychologique et sociale et un accompagnement centré sur les besoins du patient****. Elle implique la pratique de la « co-décision » ou « décision partagée » entre soignants et soigné*. »

A. Grimaldi et al. , *Les maladies chroniques. Vers la 3eme médecine,* Odile Jacob, 2017

Université Paris Cité

4) La vie d'une personne malade chronique ne peut être considérée comme satisfaisante ou source de souffrance qu'en fonction, d'abord, de ce qu'elle **éprouve et juge elle-même comme appréciable, comme normal pour elle - et non par comparaison à un modèle collectif. De sa qualité de vie, la personne malade est le premier juge.** La normalité ne peut être définie seulement en fonction de normes statistiques - qu'elles soient biologiques ou sociales -, mais **doit aussi être évaluée en fonction de l'expérience subjective, notamment psychologique et sociale, de la personne malade chronique**.

5) La **médecine** dans la maladie chronique n'a pas vocation à **adapter** la personne aux normes sociales (même si elle vise à permettre à la personne de participer à la vie sociale). Elle doit **accompagner la personne et soutenir sa capacité normative, contribuer à lui permettre d'être sujet de ses normes**, de vivre non seulement selon les contraintes que la maladie lui impose, mais aussi- et avant tout - selon les normes qu'elle juge satisfaisantes par et pour elle-même.

6) La variabilité des normes de vie entre les individus et au cours de l'existence d'un même individu ne doit pas être considérée comme un « obstacle regrettable » pour la médecine (Canguilhem). **Cela définit son statut épistémologique = un art de soigner des individus tous singuliers, et non une science des généralités.**

Université Paris Cité

A LIRE SANS APPRENDRE

Bien d'autres enjeux médicaux, sociaux et éthiques sont à prendre en compte… et n'ont pu être traités dans ce cours

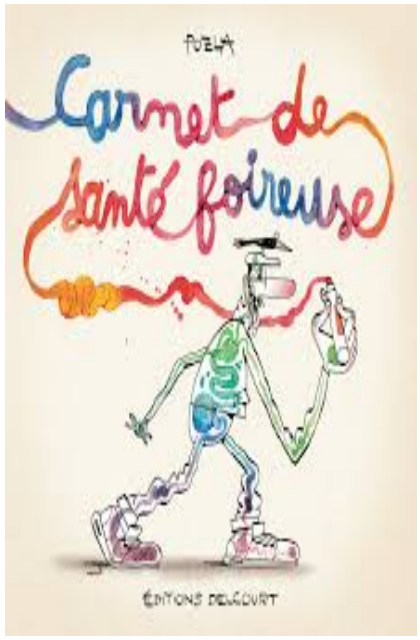
- Promotion de la prévention (lutte contre alcool, tabac, sédentarité, risques environnementaux)
- Lutte contre les inégalités sociales d'accès aux soins (pour des raisons financières, territoriales)
- Organisation du système de soin en vue de la coordination, du travail d'équipe entre les professionnels, la médecine de ville et l'hôpital, les centres de soins de suite et de rééducation, les Ehpad, les aidants, l'ensemble des intervenants dans l'accompagnement du malade
- Intégration des patients dans les formations en santé, etc.

A LIRE SANS APPRENDRE

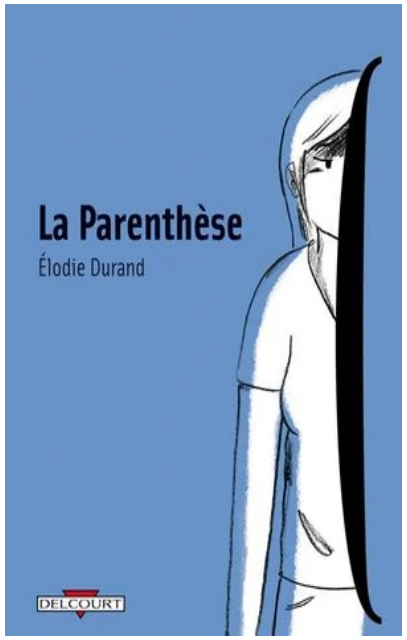
L'art nous aide souvent à mieux comprendre la vie avec la maladie chronique, ex. la bande dessinée :



Sur l'épilepsie



Sur la maladie de Crohn



Sur l'épilepsie



Sur la trisomie 21



Sur Alzheimer